

SENTETİK ÖRNEK HASTANESİ
YOĞUN BAKIM EPİKRİZ RAPORU

Adı - Soyadı : ÖRNEK HASTA ÜÇ Prot / Dosya No : 99003 / 700003

TC Kimlik No : 11111111111

Cinsiyeti - Yaş : ERKEK - 58

D.Tarihi : 22.11.1966

Kurum : ÖZEL

Bölüm Adı : Genel Yoğun Bakım Yatış Tarihi : 03.06.2023

Çıkış Tarihi : 10.06.2023

Taburcu Şekli : Şifa ile taburcu

Kesin Tanı : Aspirasyon pnömonisi, solunum yetmezliği

Apache II skoru: 16

tanısal ölüm oranı %25

Serebrovasküler olay sekeli ve disfaji öyküsü olan hasta, oral alım sırasında aspirasyon sonrası solunum sıkıntısı ile yoğun bakıma alındı; entübasyon ihtiyacı olmadı, yüksek akımlı oksijen ile takip edildi.

03.06.2023 1.GÜN

Aspirasyon pnömonisi ve solunum yetmezliği tanılarıyla izlenen hastanın genel durumu orta, GKS 11, pupiller izokorik, IR +/- . Yüksek akımlı nazal oksijen (FIO2 %60, 40 lt/dk), entübasyon gerekmedi mekanik ventilatör desteğinde; dinlemekle her iki akciğer solunum sesleri kaba ve bilateral azalmış. TA 132/78 mmHg, nabız 96/dk, ateş 38.1 C. Laboratuvar: lökosit 14800, CRP 95, kreatinin 1.1, üre 44, laktat 1.8, trombosit 210000. Hemodinamik stabil, vazopressör ihtiyacı yok. Antibiyoterapi enfeksiyon hastalıkları onayıyla Tazocin 4x4.5gr (1.gün). Kan gazı: ph 7.33 pco2 50 po2 72 hco3 22 be -2 spo2 91 sodyum 140 potasyum 4.4. Kan şekerleri 130-170 mg/dl seyretti, kristalize insülin ile regüle edildi. İdrar çıkışı diüretik infüzyonu ile yeterli, AÇT +150/24saat, CVP +2. Nazogastrik sonda ile enteral beslenme, aspirasyon önlemleri. Solunum fizyoterapisi, vücut ve kateter bakımları yapıldı. Mevcut medikal, hemodinamik ve solunum destek tedavisine devam edildi.

GLASGOW Skalası Gözler : 3 Sözel : 3 Motor : 5

05.06.2023 2.GÜN

Aspirasyon pnömonisi tanılarıyla izlenen hastanın genel durumu orta-iyi, GKS 13, pupiller izokorik, IR +/- . Yüksek akımlı nazal oksijen (FIO2 %45) mekanik ventilatör desteğinde; dinlemekle her iki akciğer solunum sesleri kaba ve bilateral azalmış. TA 130/76 mmHg, nabız 90/dk, ateş 37.6 C. Laboratuvar: lökosit 11500, CRP 60, kreatinin 1.0, üre 36, laktat 1.4, trombosit 230000. Hemodinamik stabil. Antibiyoterapi enfeksiyon hastalıkları onayıyla Tazocin 4x4.5gr (3.gün). Kan gazı: ph 7.36 pco2 46 po2 84 hco3 23 be -1 spo2 94 sodyum 139 potasyum 4.3. Kan şekerleri 120-160 mg/dl seyretti, kristalize insülin ile regüle edildi. İdrar çıkışı diüretik infüzyonu ile yeterli, AÇT +120/24saat, CVP +2. Enteral beslenme tolere edildi. Solunum fizyoterapisi, vücut ve kateter bakımları yapıldı. Mevcut medikal, hemodinamik ve solunum destek tedavisine devam edildi.

GLASGOW Skalası Gözler : 4 Sözel : 4 Motor : 5

07.06.2023 3.GÜN

Aspirasyon pnömonisi, düzelme tanılarıyla izlenen hastanın genel durumu iyi, GKS 14, pupiller izokorik, IR +/- . Nazal kanül 3 lt/dk mekanik ventilatör desteğinde; dinlemekle her iki akciğer solunum sesleri kaba ve bilateral azalmış. TA 128/76 mmHg, nabız 84/dk, ateş 37.0 C. Laboratuvar: lökosit 9200, CRP 40, kreatinin 1.0, üre 34, laktat 1.2, trombosit 260000. Trakeal aspirat kültüründe üreme olmadı; de-eskalasyon değerlendirildi. Antibiyoterapi enfeksiyon hastalıkları onayıyla Tazocin 4x4.5gr (5.gün). Kan gazı: ph 7.38 pco2 44 po2 90 hco3 24 be 0 spo2 96 sodyum 139 potasyum 4.2. Kan şekerleri 110-150 mg/dl seyretti, kristalize insülin ile regüle edildi. İdrar çıkışı diüretik infüzyonu ile yeterli, AÇT +100/24saat, CVP +1. Enteral beslenme tam doz, aspirasyon gözlenmedi. Solunum fizyoterapisi, vücut ve kateter bakımları yapıldı. Mevcut medikal, hemodinamik ve solunum destek tedavisine devam edildi.

GLASGOW Skalası Gözler : 4 Sözel : 4 Motor : 6

10.06.2023 4.GÜN

Aspirasyon pnömonisi, iyileşme tanılarıyla izlenen hastanın genel durumu iyi, GKS 15, pupiller izokorik, IR +/- . Oda havasında satürasyon %98 mekanik ventilatör desteğinde; dinlemekle her iki akciğer solunum sesleri kaba ve bilateral azalmış. TA 124/72 mmHg, nabız 78/dk, ateş 36.6 C. Laboratuvar: lökosit 6800, CRP 12, kreatinin 0.9, üre 28, laktat 1.0, trombosit 300000. Ek oksijen ihtiyacı yok, hemodinamik stabil. Antibiyoterapi enfeksiyon hastalıkları onayıyla Tazocin 4x4.5gr (7.gün, tamamlandı). Kan gazı: ph 7.41 pco2 40 po2 95 hco3 25 be 1 spo2 98 sodyum 138 potasyum 4.1. Kan şekerleri 100-140 mg/dl seyretti, kristalize insülin ile regüle edildi. İdrar çıkışı diüretik infüzyonu ile yeterli, AÇT +120/24saat, CVP +1. Oral alım güvenli, yutma değerlendirmesi planlandı. Solunum fizyoterapisi, vücut ve kateter bakımları yapıldı. Mevcut medikal, hemodinamik ve solunum destek tedavisine devam edildi.

GLASGOW Skalası Gözler : 4 Sözel : 5 Motor : 6

